

แบบรายงานการประเมินตนเอง (Service Profile)

หอผู้ป่วย กุมารเวชกรรม

30 ตุลาคม 2568

1. บริบท¹ (Context)

ก. ความมุ่งหมาย (Purpose)

ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยที่มาใช้บริการห้องพิเศษ อย่างมีมาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัย มีความพึงพอใจ

ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service)

ให้บริการผู้ป่วยเด็กที่เจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม ศัลยกรรมกระดูก โสต คอ นาสิก จักษุ และจิตเวช อายุ 29 วัน – 15 ปี

ค. ความต้องการของผู้รับผลงานสำคัญทั้งภายนอก/ภายใน

ผู้รับผลงานภายนอก	ความต้องการที่ตอบสนองได้ดี	ความต้องการที่ยังตอบสนองได้ไม่ดี
ผู้ป่วยและญาติ	- ได้รับการบริการที่รวดเร็ว - รับทราบข้อมูลเรื่องการเจ็บป่วยและวิธีการปฏิบัติตัว - ผู้ให้บริการมีพฤติกรรมบริการที่ดี	
โรงพยาบาลมหาราช	- ผู้ป่วย Refer ได้รับการประสานงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน - ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน และ ปลอดภัย ขณะ Refer	

ผู้รับผลงานภายใน	ความต้องการที่ตอบสนองได้ดี	ความต้องการที่ยังตอบสนองได้ไม่ดี
แพทย์	-การประเมินและดูแลผู้ป่วยที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน -ให้การดูแลผู้ป่วยถูกต้องครบถ้วน และได้มาตรฐาน -การรายงานผู้ป่วยถูกต้อง รวดเร็ว	
	-ต้องการการนัดที่ถูกต้อง -ต้องการความพร้อมในการรับผู้ป่วย Admitted ถูกต้อง รวดเร็ว	
ER	-ต้องการความพร้อมในการรับผู้ป่วย Admitted ถูกต้อง รวดเร็ว	
ห้องผ่าตัด	- การเตรียมผู้ป่วยเพื่อรับผ่าตัดอย่างถูกต้อง	
ห้องLAB	- Key Lab และส่ง Specimen ถูกต้อง ทันเวลา	
VIP	-การประสานงาน เอกสารและผู้ป่วยถูกต้อง	
ห้องเอกซเรย์	-การKeyข้อมูลถูกต้อง ส่งผู้ป่วยไปX-Ray ถูกต้อง , เวลา	
ห้องยา	- Order ถูกต้อง -มารับยาตรงเวลา	
ศูนย์แปล	-การประสานงานผู้ป่วยถูกต้อง เหมาะสม	
งานโภชนาการ	-การ Key ประเภทยาอาหารผู้ป่วยถูกต้อง ครบถ้วน	
งานซ่อมบำรุง	-การ Key ส่งซ่อม ถูกต้อง	
เวชระเบียน	-การส่ง Chart ที่ถูกต้อง และ ตรงเวลา	

ง. ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณงาน

ปริมาณงาน	ปี2564	ปี2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1.จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดต่อปี	1186	1519	2219	2821	2829
2.จำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยต่อวัน	10	12.96	17.47	20.91	20.09

¹ เขียนอย่างสรุป สามารถใช้ตารางสรุปในบางเรื่องได้

3.จำนวนวันนอนทั้งหมด	3673	4730	6377	7652	7524
4.จำนวนวันนอนเฉลี่ย	3.10	3.11	3.14	2.72	2.7
5.อัตราครองเตียง (30 เตียง)	34%	43.14	58.36	68.29	68.13
6.ร้อยละของผลผลิต(Productivity)	70.72	74	111.64	197.73	170.34
7. จำนวนผู้ป่วย Refer ทั้งหมด	24	28	32	44	41
- จำนวนผู้ป่วย Refer 24 ชั่วโมง	7	4	13	11	8
8.จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตทั้งหมด(ราย)	1	0	1	2	1

จำนวนกลุ่มโรคสูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	โรค	รหัส	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
1	AGE	A09	149	131	335	563	292
2	Bronchitis	J209	77	95	210	214	156
3	Pneumonia	J189 180	128	93	187	180	367
4	Febrile convulsion	R560	51	42	104	81	59
5	DF DHF	A97	0	7	75	134	38

จำนวนกลุ่มโรคเสียชีวิตสูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	โรค	รหัส	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
1	Malignant neoplasm of brain	C719	1	0	0	0	0
2	Pulmonary Embolism (Closed Fracture Tibial Plateau)		0	0	1	0	0

จำนวนกลุ่มโรคความเสี่ยงสูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	โรค	รหัส	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
1	Pneumonia	J189 180	128	93	187	74	292
2	Febrile convulsion	R560	51	42	104	41	59
3	Epilepsy	G409	26	26	42	15	34
4	DF DHF	A97	0	7	75	41	38
5	AGE	A09	149	131	335	152	292

จำนวนกลุ่มโรค Readmission สูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	โรค	รหัส	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
1	Bronchitis	J209	NA	1	0	0	3
2	Epilepsy	G409	NA	1	0	0	4
3	Pneumonia	J189 180	NA	0	1	0	8
4	AGE	A990	NA	NA	NA	0	3
5	acute bronchiolitis		NA	NA	NA	0	2

จำนวนกลุ่มโรค Refer out สูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	โรค	รหัส	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
-------	-----	------	--------	--------	--------	--------	---------

1	Pneumonia	J189 180	4	2	2	3	4
2	Febrile convulsion	R560	2	2	0	3	7
3	Epilepsy	G409	7	2	0	2	2
4	Kawasaki		0	2	3	1	0
5	Fever		2	1	0	0	0

จำนวนกลุ่มโรค Refer in สูงสุด 5 ลำดับแรก

ลำดับ	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี 2567	ปี2568
1	NA	1st Episode seizure (1)	Thalassemia (2)	Dengue fever (1)	Febrile convulsion (4)
2	NA	Epilepsy (1)		CFx temperal bone (2)	Acute pharyngitis (3)
3	NA			Partial achilles tendon tear Lt (3)	Pneumonia (1)
4	NA				AGE (1)
5	NA				CFx Humerus (1)

จ. ทรัพยากร

ทรัพยากร	สิ่งที่เข้มแข็ง	สิ่งที่ต้องพัฒนา
สถานที่	บริเวณหอผู้ป่วย ดูแลความสะดวกง่าย ไม่แออัด มีระเบียบระบายอากาศได้ดี	บริเวณฝ้าเพดานค่อนข้างเก่าต้องซ่อมแซม ดำเนินการเขียนโครงการซ่อมแซม
เทคโนโลยี 1.โปรแกรม HOS XP, KPHIS 2. Application line	มีอุปกรณ์ PC computer, Computer Note book, โทรศัพท์มือถือเพื่อประสานงาน ใช้เพียงพอ	Computer Note book ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้งาน
เครื่องมือ 1.Defibrillator 1 เครื่อง 2.NIBP 2 เครื่อง 3.Infusion pump 6 เครื่อง 6.Syringe pump 1 เครื่อง	มีเครื่องมือแพทย์ประจำหอผู้ป่วย และสามารถยืมใช้เพิ่มเติมจากศูนย์เครื่องมือแพทย์ได้	
เวชภัณฑ์	ใช้ระบบ KPHIS	ยังต้องมี เจ้าหน้าที่เดินรับยาที่ห้องยาชั้น 3 อาคาร 100 ปี เกิดความล่าช้า และรอคอย
บุคลากร 1. กุมารแพทย์ 6 คน 2. Neonatologist 1 คน 3. พยาบาลวิชาชีพ 8 คน - NP เด็กเรื้อรัง 1 คน - NP เด็กระยะวิกฤต 1 คน - NP พัฒนาการเด็ก 1 คน 4. ผู้ช่วยพยาบาล 3 คน 5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คน	พยาบาลมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 33 มากกว่า 5 ปี ร้อยละ 56	จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 1) บริหารการพยาบาล 1 คน 2) NP ผู้ป่วยเด็กวิกฤตเพิ่ม 1 คน(รองรับ PICU) 3) ส่งอบรมภายในโดยแพทย์เฉพาะทางและNPแต่ละสาขา ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย 4. จัดอัตรากำลัง 1 : 8

ฉ. นโยบาย/จุดเน้น/ยุทธศาสตร์ขององค์กร

นโยบาย/จุดเน้น/ยุทธศาสตร์	แนวทางตอบสนองที่มีอยู่	สิ่งที่ต้องพัฒนา
การพัฒนากระบวนการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูง สาขาการเวชกรรม <u>เป้าประสงค์</u> 1. ลดอัตราป่วยและตาย	1.พัฒนาระบบ REFER 2.สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบทางเดินหายใจ 3.รณรงค์การฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงในเด็กโรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์	1. เปิดบริการ PICU 2 เตียง 2. พัฒนาศักยภาพพยาบาล 1)เพิ่มแพทย์ทางเดินหายใจ 2)เพิ่มแพทย์พยาบาลNPทางเดินหายใจในเด็ก

ในผู้ป่วย Pneumonia อายุ 29 วัน - 15 ปี		3. สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยเด็กระบบ ทางเดินหายใจ
2. ลดอุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม	ปฏิบัติตามมาตรฐาน WI การเฝ้าระวังพลัดตก หกล้ม	1. จัดทำ WI การเฝ้าระวังพลัดตกหกล้ม 2. ติดป้ายสัญลักษณ์ 3. ทบทวนกระบวนการแนวทางการปฏิบัติ
3. ลดอุบัติการณ์คลาดเคลื่อนทางยา	บริหารยาที่ถูกต้อง ปลอดภัยตามหลัก 10R	1. จัดทำ WI คู่มือการบริหารยา เภสัชกรมีส่วนร่วมในการทบทวนเคส Med error ระดับ E ขึ้นไป
4. ไม่เกิดอุบัติการณ์ความผิดพลาดในการ ให้เลือดและหรือส่วนประกอบของเลือด	ปฏิบัติตามมาตรฐาน WI การให้เลือดและ ส่วนประกอบของเลือด	ทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน WI การให้ เลือดและส่วนประกอบของเลือด

ข. ประเด็นคุณภาพและตัวชี้วัดที่สำคัญ(Key Quality Issues & Key Performance Indicator)

ประเด็นคุณภาพ	ตัวชี้วัดที่สำคัญ
ผู้ป่วย Pneumonia มีความปลอดภัย	1. อัตราการเสียชีวิตใน ผู้ป่วยPneumonia 2. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Sepsis shock ในผู้ป่วย Pneumonia 3. ร้อยละของผู้ป่วย Pneumoniaที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้รับการส่งต่อ HHC 4. ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรค Pneumonia
ผู้ป่วย Febrile convulsion มีความปลอดภัย	1. อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำ 2. ร้อยละของผู้ป่วย Febrile convulsion ที่มีภาวะชักซ้ำในโรงพยาบาล ได้รับการ การส่งต่อ HHC 3. ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำด้วยFebrile convulsion
ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ได้รับการที่รวดเร็ว ปลอดภัย ไม่เกิด ข้อผิดพลาด และภาวะแทรกซ้อน	1. อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาโดยพยาบาล 2. อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม 3. อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล (HAP)

ข. ความเสี่ยงสำคัญและมาตรการป้องกัน

ความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
1. ผู้ป่วยเด็กเสียชีวิตโดยมิได้คาดหมาย	1. ทบทวนการประเมิน Early warning signs 2. พัฒนาศักยภาพ จัด CPR 1 ครั้ง/2 เดือน 3. เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ พร้อมใช้
2. Refer ภายใน 24 ชั่วโมงหลัง Admit	1. ได้รับการตรวจและ Admit โดยแพทย์กุมารแพทย์ 2. ทบทวนการประเมิน Early warning signs 3. ประเมินผู้ป่วยวิกฤตตามแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 4. ทบทวนแนวทางการ Refer รายโรค
3. ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาโดยพยาบาล	1. จัดทำแนวทางการบริหารยาในผู้ป่วยเด็ก 2. ตรวจสอบใบบันทึกการให้ยาขณะรับส่งเวร 3. ตรวจสอบยาที่มีใน LOCK ยาอย่างละเอียด ทุกเวร 4. แยกและคืนยาเมื่อแพทย์มีคำสั่ง OFF
4. การพลัดตกหกล้ม	1. ประเมินผู้ป่วยแรกรับทุกราย 2. ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือผู้ดูแลร่วมเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตั้งแต่แรกรับ 3. จัดเตียงผู้ป่วย ตามความเสี่ยง 4. มีการส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงขณะรับส่งเวร 5. ติดป้ายสัญลักษณ์เฝ้าระวัง 6. พยาบาลตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอ

2. กระบวนการสำคัญ (Key Processes)²

กระบวนการสำคัญ (Key Process)	สิ่งที่คาดหวัง (Process Requirement)	ความเสี่ยงสำคัญ (Key Risk)	ตัวชี้วัดกระบวนการที่สำคัญ (Key Process Indicator)
1. การเข้าถึงและเข้ารับบริการ	. ผู้ป่วยได้รับการ admit ที่รวดเร็วภายใน 30 นาที - หอผู้ป่วยมีความพร้อมรับผู้ป่วย	- ความล่าช้าในการ admitted - การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถูกต้องและเหมาะสม	การเตรียมความพร้อมในการ Admitted - อุบัติการณ์ความล่าช้าในการ admitted - อุบัติการณ์การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่เหมาะสม
2. การประเมินผู้ป่วย - การประเมินโดยแพทย์ ก่อน ADMITTED - การประเมินซ้ำที่ WARD โดยพยาบาลในระยะแรกเริ่มและต่อเนื่อง	ผู้ป่วยทุกรายได้รับการประเมินความต้องการและปัญหาสุขภาพอย่างถูกต้องครบถ้วนและเหมาะสมโดยกุมารแพทย์ และพยาบาล	ประเมินอาการผู้ป่วยไม่ครอบคลุม	Early Warning signs - จำนวนครั้งการประเมินอาการผู้ป่วยไม่ครอบคลุม - อัตราผู้ป่วยเสียชีวิตไม่คาดฝัน - อัตรา Refer ใน 24 ชม. หลัง admitted
3. การดูแลผู้ป่วย	ผู้ป่วยปลอดภัย	ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการดูแล	Early Warning signs CPG รายโรค Focus Charting รายโรค 1. อัตราการติดเชื้อ HAP 2. อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำในผู้ป่วย Febrile convulsion 3. อัตราการเกิด Prolong shock และภาวะ น้ำเกินในผู้ป่วย DHF 4. จำนวนครั้งการพลัดตก หกล้ม / ตกเตียง 5. อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา 6. ร้อยละความพึงพอใจ
5. การให้ข้อมูลและเสริมพลังแก่ผู้ป่วย / ครอบครัว	- ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสุขภาพ เพื่อให้มีความสามารถและรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของตนเอง	- ผู้ป่วยและญาติไม่ได้รับทราบข้อมูลด้านสุขภาพ	การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวรายโรคผ่านพบคำแนะนำเมื่อกลับบ้าน - ร้อยละของผู้ป่วยและครอบครัวมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
6. การดูแลต่อเนื่อง	- ผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้านได้แก่ case Palliative , ชัก , จิตเวช	ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลตามแบบแผน	- CPG Palliative - ร้อยละผู้ป่วยได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

การวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

หัวข้อ	ความสูญเสีย	แนวทางแก้ไข Proposed solution
Defect rework ทำงานซ้ำ	เจ้าหน้าที่ทำงานซ้ำ	ทำงานตามที่ได้รับ Assignment
Overproduction การผลิตหรือให้บริการมากเกินไป	-	-
Waiting การรอคอย	ผู้ป่วยรอรับยากลับบ้านนาน ข้อจำกัดด้านเจ้าหน้าที่	ให้ญาติผู้ป่วยรับยากลับบ้านเองโดยใช้ บัตรรับยาดัดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย
Not-Utilized talent ภูมิรู้ที่สูญเปล่า	-	-
Transportation การเดินทาง	ผู้รับบริการต้องพิเศษเดินไปชำระเงินค่าห้อง และเดินไปรับยาที่บ้าน โดยบางเคสเดิน	ให้ญาติผู้ป่วยเดินไปชำระเงิน และรับยาในครั้งเดียว
Inventory วัสดุคงคลัง	เบิกพัสดุเกินความจำเป็น พัดลมต้ออายุก่อนการใช้งาน	ทบทวนการเบิกใช้พัสดุ เบิกเท่าที่ใช้งาน โดยกำหนดจำนวน Stock ที่แน่นอน
Motion การเคลื่อนไหว	โทรศัพท์ภายใน อยู่ห่างจากโต๊ะทำงานของพยาบาลหัวหน้าเวร	วางโทรศัพท์ไว้บริเวณโต๊ะทำงานของหัวหน้าเวรเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน
Excessive processing ขั้นตอนมากเกินไป		

² สรุปภายใน 1 หน้า วิเคราะห์โดยเน้นผู้รับผลงานเป็นศูนย์กลาง เช่น หอผู้ป่วย ให้พิจารณาว่ามีกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างไร โดยทุกวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีเฉพาะกระบวนการที่พยาบาลรับผิดชอบ

3. การดำเนินการพัฒนาคุณภาพในรอบปีปัจจุบัน

ประเด็นคุณ /ความท	อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำ			
1.การดูแลผู้ป่วย				
2.การดูแลผู้ป่วย convulsion	2564	2565	2566	2567
	2568			
				2. เหน็บการให้ความรู้สำหรับผุ้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง อาการชัก 3. สอนและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเช็ดตัวลดไข้ ช่วยญาติ ผู้ป่วยเช็ดตัวลดไข้
3.การบริหารยาโดยพยาบาล	1.ลดความคลาดเคลื่อน ทางยาโดยพยาบาล	1.อัตราความคลาด เคลื่อนในการบริหารยา โดยพยาบาล	1.พัฒนาระบบการรับส่งอาการผู้ป่วย โดยการตรวจสอบใบ บันทึกการให้ยาทุกเวรจากระบบ E-MAR 2.พัฒนาระบบการตรวจสอบ ระบบยาประจำเวร โดยการ ตรวจสอบยาที่มีใน LOCK ยา อย่างละเอียด รอบคอบ	
4.การป้องกันการพลัดตก หกล้ม	1.ลดอัตราการพลัดตก หกล้ม	1.อุบัติการณ์ของการ พลัดตกหกล้ม	1. พยาบาลเดิน ROUND สม่ำเสมอ ต่อเนื่อง 2. เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยการชี้แจงและขอความ ร่วมมือผู้ดูแลผู้ป่วยให้ช่วยเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3. ติดป้ายเตือน 4. ทำแบบประเมิน Risk Fall ทุกราย	

4. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน³ (Performance Indicator)

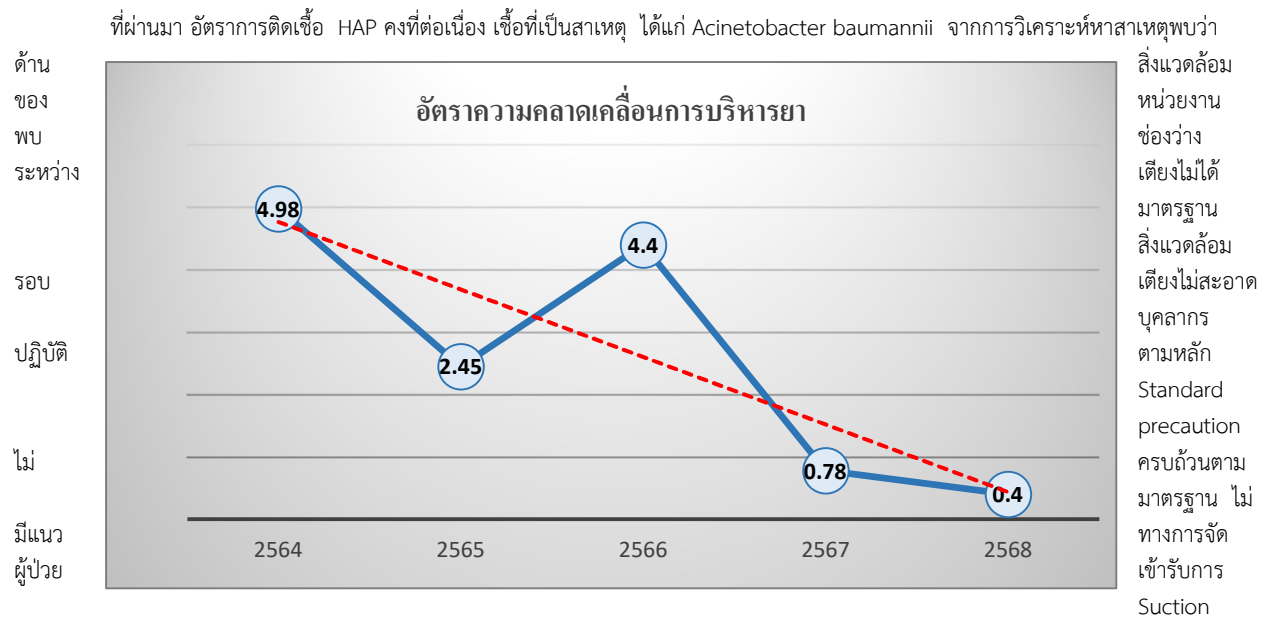
ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ปี2564	ปี2565	ปี2566	ปี2567	ปี 2568
1. อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำ ในผู้ป่วย Febrile convulsion	0	2.36 (28)	0.72 (11)	0.45 (10)	0.71 (20)	0.39 (11)
2. อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล (HAP)	0	0.18 (1)	0.41 (1)	0 (0)	0.13 (1)	(0)
3. อัตราความคลาดเคลื่อนในการ บริหารยาโดยพยาบาล :1000วันนอน	ลดลง จากเดิม	4.98 (24)	2.45 (9)	4.4 (44)	0.78 (6)	0.4 (3)
4. อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม	0	0.92 (4)	0.81 (3)	0.78 (5)	0.98 (5)	0.93 (7)

อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำ ในผู้ป่วย Febrile convulsion

³ นำเสนอกราฟแสดงข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ (ก) ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและมีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง (พร้อมคำอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นประกอบภาพอย่างสั้นๆ) (ข) ข้อมูลผลการพัฒนาตามโครงการสำคัญในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา



อุบัติการณ์การติดเชื้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล (HAP)



ปีงบประมาณ 2565 ได้พัฒนาระบบงาน ดังนี้

- 1.ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักในเรื่อง Bed side nursing care ส่งเสริมความร่วมมือของผู้ดูแลผู้ป่วย โดยการจัดประกวดเตียงสะอาด
- 2.ด้านบุคลากร เน้นเรื่อง Standard precaution โดยเฉพาะการล้างมือ
- 3.กระบวนการ Suction จัดลำดับการ Suction โดยใช้ ตาราง Suction score
- 4.กระบวนการนิเทศ ดูแลกำกับติดตามงานอย่างต่อเนื่องโดยหัวหน้าหน่วยงาน และประเมินสมรรถนะบุคลากรในเรื่อง การ Suction

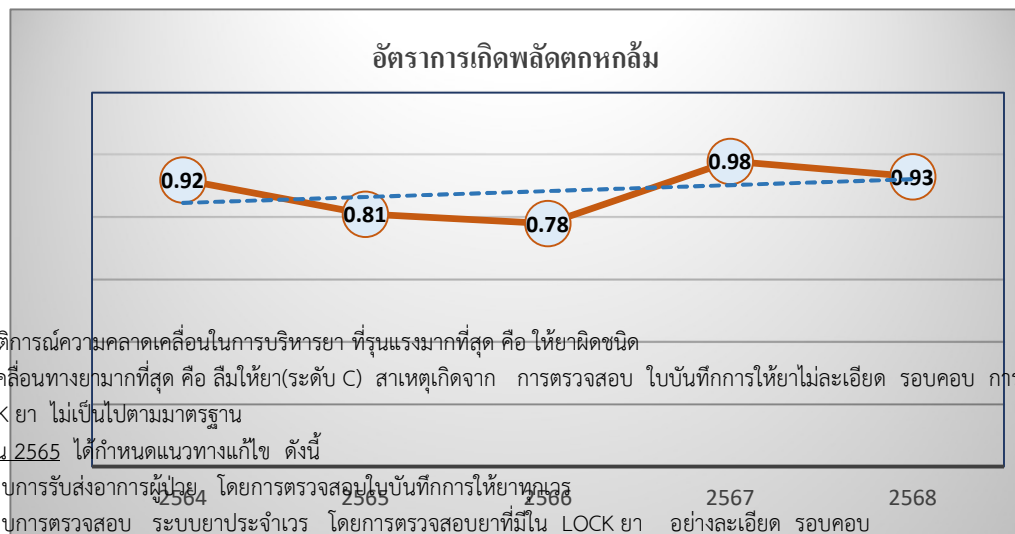
ผลลัพธ์ : อัตราการติดเชื้อปอดอักเสบในโรงพยาบาล HAP เป็น 1

ปีงบประมาณ 2566 ผลการดำเนินงาน HAP เป็น 0

ปีงบประมาณ 2567 ผลการดำเนินงาน HAP เป็น 1

ปีงบประมาณ 2568 ผลการดำเนินงาน HAP เป็น 0

อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาโดยพยาบาล



อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา ที่รุนแรงมากที่สุด คือ ให้ยาผิดชนิด
ความคลาดเคลื่อนทางยามากที่สุด คือ สลิมให้ยา(ระดับ C) สาเหตุเกิดจาก การตรวจสอบ ใบบันทึกการให้ยาไม่ละเอียด รอบคอบ การตรวจสอบยา
ที่มีใน LOCK ยา ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ปีงบประมาณ 2565 ได้กำหนดแนวทางแก้ไข ดังนี้

- 1.พัฒนาระบบการรับส่งอาการผู้ป่วย โดยการตรวจสอบใบบันทึกการให้ยาทุกวัน
- 2.พัฒนาระบบการตรวจสอบ ระบบยาประจำเวร โดยการตรวจสอบยาที่มีใน LOCK ยา อย่างละเอียด รอบคอบ

ผลลัพธ์ : อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาโดยพยาบาลลดลง
ปีงบประมาณ 2566 มีแผนการพัฒนารายการโดย

- 1.จัดทำแนวทางบริหารยาในผู้ป่วยเด็ก
- 2.ตรวจสอบใบบันทึกการให้ยาขณะรับส่งเวร
- 3.ตรวจสอบที่มีในLOCKยาอย่างละเอียด ทุกเวร
- 4.แยกและคืนยาเมื่อแพทย์มีคำสั่งOFF

ปีงบประมาณ 2567 เปลี่ยนระบบการบันทึกการบริหารยาโดยใช้ E-MAR ผ่านโปรแกรม KPHIS (เริ่มต้นเต็มรูปแบบ เดือนมีนาคม 2567) แผนพัฒนา
เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ตรวจสอบOrder ทุกครั้ง โดยใช้ การยิง Barcode ชื่อชื่อยาและสติ๊กเกอร์ผู้ป่วย(Double check)ก่อนการบริหารยา
ผลลัพธ์ : อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแนวโน้มลดลง
ปีงบประมาณ 2568 ระบบการบันทึกการบริหารยาโดยใช้ E-MAR ผ่านโปรแกรม แผนพัฒนาเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด กำกับ ติดตาม การใช้ WI การ
บริหารยา และตรวจสอบOrder ทุกครั้ง Double check ก่อนการบริหารยา
ผลลัพธ์ : อัตราการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาแนวโน้มลดลง

อัตราการเกิดผิดพลาดทหกล้ม

อุบัติการณ์ของการพลัดตกหกล้ม พบการตกเตียงมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจาก การเฝ้าระวังเรื่องการพลัดตกหกล้มตกเตียง ไม่รัดกุม
ปีงบประมาณ 2565 ได้เพิ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยการชี้แจงและขอความร่วมมือผู้ดูแลผู้ป่วยให้ช่วยเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่ม
การเดิน Roundภายในเวร

ผลลัพธ์ :อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม ยังเพิ่มขึ้น

ปีงบประมาณ 2566 มีแผนการพัฒนากการโดย

- 1.ประเมินผู้ป่วยารรับทุกราย
- 2.ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือผู้ดูแลร่วมเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตั้งแต่แรกรับ
- 3.จัดเตียงผู้ป่วย ตามความเสี่ยง
- 4.มีการส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงขณะรับส่งเวร
- 5.ติดป้ายสัญลักษณ์เฝ้าระวัง
- 6.พยาบาลตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอ

ผลลัพธ์ :อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มลดลงแต่ยังคงมีอยู่

ปีงบประมาณ2567 อุบัติการณ์พลัดตกหกล้มสูงขึ้น แผนการพัฒนา โดย

- 1.ให้คำแนะนำผู้ปกครองเรื่องการยกยกร่างกันเตียง
- 2.ดูแลติดป้ายคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยทุกเตียง
- 3.กำกับ ติดตาม ตามเตียงผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง

ปีงบประมาณ 2568 ผลลัพธ์ :อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มลดลง แต่ยังมีอุบัติการณ์การเกิดขึ้น

- 1.ให้คำแนะนำผู้ปกครองเรื่องการยกยกร่างกันเตียง
- 2.ดูแลติดป้ายคำแนะนำการดูแลผู้ป่วยทุกเตียง
- 3.กำกับ ติดตาม ตามเตียงผู้ป่วยทุก 2 ชั่วโมง

ผลลัพธ์ : อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้มลดลง เป็น 0.93

5. กิจกรรมทบทวนคุณภาพ

กิจกรรมทบทวนคุณภาพ	วิธีการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม	กรณีตัวอย่าง	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
การทบทวนขณะดูแล ผู้ป่วย/ทำงาน	โดยพยาบาลในเวร ทบทวน เบื้องต้น และนำเสนอในที่ประชุม	Case Refer (Dead) Dx : Pneumonia VSD with congestive heart failure เด็กชายชาว ลาว อายุ 9 ปี ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลด้วย อาการเหนื่อยหอบ CXR : Bilateral reticulonodular infiltration มีอาการ เหนื่อยหอบ มากขึ้น มีไข้ แพทย์พิจารณา ส่งต่อโรงพยาบาลมหาราช ผู้ป่วยเสียชีวิต ในเวลาต่อมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง พยาธิสภาพของโรค	จากการทบทวนเคส ปรับปรุง ระบบการโทรปรึกษา โรงพยาบาลศูนย์ เพื่อวาง แผนการรักษาร่วมกัน หรือ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับรักษา ต่ออย่างทันท่วงที
การทบทวนการส่งต่อ/ขอย้าย/ ปฏิเสธการรักษา	PCT ประจำเดือน สื่อสารผลการ ประชุมผ่าน Line Group Ward		
การค้นหาและป้องกัน ความเสี่ยง	-หัวหน้าทีม ความเสี่ยงเชิงรุกทั้ง ด้าน สิ่งแวดล้อม และทางคลินิก ทุกวันเวรเช้า -มีระบบรายงานความเสี่ยง		
การทบทวนความคิดเห็น/คำ ร้องเรียนของผู้รับ บริการ	-เมื่อมีเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงที่อาจก่อ ให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน และ ความไม่พึงพอใจในบริการ ให้ รายงานหัวหน้าเวร/หัวหน้าหอ		การเฝ้าระวังเหตุไม่พึง ประสงค์ที่อาจก่อให้เกิดการ ร้องเรียน รพ.

กิจกรรมทบทวนคุณภาพ	วิธีการ/ความถี่/ผู้เข้าร่วม	กรณีตัวอย่าง	การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	ผู้ป่วยทันที		
การทบทวนโดยผู้ชำนาญกว่า	มีการทบทวนสอบการดูแลขณะ รับ-ส่งอาการผู้ป่วย		
การป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล	มีแนวทางการปฏิบัติและระบบการจัดการและมีการทบทวนเมื่อเกิดอุบัติการณ์การติดเชื้อ		
การป้องกันและเฝ้าระวังความคลาดเคลื่อนทางยา	มีแนวทางการปฏิบัติและระบบการจัดการ และมีการทบทวนเมื่อเกิดอุบัติการณ์ ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติ		
การทบทวนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน	มีระบบตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน ตามรอบ พร้อมรายงานผลให้หน่วยงานทราบ		
ทบทวนการใช้ทรัพยากร	มีการตรวจสอบความพร้อมใช้ของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และมีระบบยืม-คืน จากศูนย์เครื่องมือแพทย์		
การทบทวนการใช้ข้อมูลวิชาการ	มีการ Update แนวทางปฏิบัติที่สำคัญอยู่เสมอ		
การติดตามเครื่องชี้วัดสำคัญ	มีการรายงานตัวชี้วัดสำคัญในที่ประชุม QA ทุกเดือน		
การทบทวนการดูแลผู้ป่วยจากเหตุการณ์สำคัญ	มีการทบทวนตามความเร่งด่วนของระดับความเสี่ยง		

6.ผลงานที่ภาคภูมิใจ

ผลงาน	การเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ยังใช้ถึงปัจจุบัน	เริ่มเมื่อ	ผลลัพธ์
โครงการ High Fever without convulsion โดยนางสาวศิริลักษณ์ เจริญทรัพย์ นำเสนอผลงาน HACC FORUM 16	การปรับแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลในผู้ป่วย Febrile convulsion -เมื่อมีผู้ป่วย Febrile convulsion เข้ารับการรักษาที่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ทีมพยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์เซ็ดตัวลดไข้ให้พร้อมใช้ -ใน 24 ชม.แรก ประเมินอุณหภูมิกายทุก 1 ชม. และให้การพยาบาลเซ็ดตัวลดไข้ ดังนี้ BT < 39 C เซ็ดตัวลดไข้โดยผู้ช่วยเหลือคนไข้ BT > 39 C เซ็ดตัวลดไข้โดยพยาบาล และผู้ดูแลได้รับการสอนและสาธิตการเซ็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้อง -วันที่ 2 ของการนอนโรงพยาบาล ทีมพยาบาลจัด Fever corner ให้ความรู้เรื่องสาเหตุ การดูแลและการเฝ้าระวังอาการชักซ้ำกับผู้ดูแลผู้ป่วยทุกคน -วางแผนการจำหน่ายโดยการจัดตั้ง line group เพื่อให้คำปรึกษาการดูแลเด็กต่อเนื่องเมื่อมีภาวะไข้ที่บ้าน	1 ธันวาคม 2565-30 กันยายน 2566	ผลการดำเนินงาน 1 ธ.ค.65-30 มิ.ย.66 -มีผู้ป่วย Febrile convulsion จำนวน 59 คน เกิดชักซ้ำขณะนอนโรงพยาบาลจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 -ผู้ปกครองเข้าร่วม line group ร้อยละ 15.27

7. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง⁴

⁴ อาจระบุทิศทางของการพัฒนา, โครงการสำคัญที่วางแผนไว้ หรืออาจจะระบุรายละเอียดของโครงการ (วัตถุประสงค์ ระยะเวลา ข้อมูลที่จะใช้ติดตามกำกับ)

ประเด็นคุณภาพ /ความท้าทาย	โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	กำหนดดำเนินการ
1. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Pneumonia	1.ให้ความรู้ Standard precaution 2.ให้ความรู้ผู้ดูแล ขณะผู้ป่วย ON HHHFNC (Heated Humidified High Flow Nasal Cannula) 2.จัดลำดับการ Suction 3.การฝึกการหายใจ พร้อมกับมีการเคลื่อนไหวนอก 4.ให้ความรู้ผู้ดูแล การดูแลผู้ป่วย ที่บ้าน	1.ลดอัตราการเสียชีวิตและการเกิดภาวะแทรกซ้อน	1.อัตราการเสียชีวิตใน ผู้ป่วย Pneumonia 2.อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Sepsis shock 3.ร้อยละของผู้ป่วย Pneumoniaที่เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ส่ง HHC 4.ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 5.ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำด้วยโรค Pneumonia	ตค.68-ก.ย.69 พว.ชัยภูวนุช พว.วาสนา
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย Febrile convulsion	1.ประเมินอาการผู้ป่วย และประวัติการชัก เมื่อแรกเริ่ม ในผู้ป่วยทุกราย 2.จัด Fever Corner ให้ความรู้ เรื่องภาวะไข้ การสังเกต และเฝ้าระวังอาการชัก เป็นกิจกรรมการพยาบาลหลัก เวรเช้า 3.จัดเตียงผู้ป่วย ใกล้ Nurse Station 4.วัดปรอททุก 2 ชม ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เช่น DHF FC หรือผู้ป่วยโรคอื่นที่มีไข้มากกว่า 38.5 องศา 5.ให้บริการ Line Group: Fever Group เพื่อให้คำปรึกษา การดูแลเด็กเมื่อมีภาวะไข้ที่บ้าน	1.ลดการเกิดภาวะชักซ้ำ	1.อัตราการเกิดภาวะชักซ้ำ 2.ร้อยละของผู้ป่วย Febrile convulsionได้ส่ง HHC 3.ร้อยละของผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน 4.ร้อยละของการกลับมารักษาซ้ำด้วย Febrile convulsion	ตค.68-ก.ย.69 พว.สุภาวดี
3. พัฒนาระบบการบริหารยาโดยพยาบาล	1.จัดทำแนวทางบริหารยาในผู้ป่วยเด็ก 2.ตรวจสอบการบันทึกการให้ยา E-MARขณะรับส่งเวร 3.ตรวจสอบที่มีใน LOCK ยาอย่างละเอียด ทุกเวร 4.แยกและคืนยาเมื่อแพทย์มีคำสั่ง OFF	1.ลดความคลาดเคลื่อนทางยาโดยพยาบาล	1.อัตราความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาโดยพยาบาล 2.ร้อยละของความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ	ตค.68- กย.69 พว.ณิศาภัคสุภา
4. พัฒนาระบบการป้องกันการพลัดตกหกล้ม	1.ประเมินผู้ป่วยแรกเริ่มทุกราย 2.ให้คำแนะนำ และขอความร่วมมือผู้ดูแลร่วมเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตั้งแต่แรกเริ่ม 3.จัดเตียงผู้ป่วย ตามความเสี่ยง 4.มีการส่งต่อข้อมูลความเสี่ยงขณะรับส่งเวร 5.ติดป้ายสัญลักษณ์เฝ้าระวัง 6.พยาบาลตรวจเยี่ยมสม่ำเสมอ	1.ลดอัตราการพลัดตกหกล้ม	1.อุบัติการณ์การพลัดตกหกล้ม 2.ร้อยละของผู้ป่วยที่เกิดการพลัดตกหกล้ม ไม่ได้รับการประเมินความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติ	ตค.68-กย.69 พว.ศิริลักษณ์